



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO PAUDALHO

**APOSTILA DA DISCIPLINA DE
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR TÁTICO**

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS



APH-TÁTICO

Atendimento Pré-Hospitalar Tático para profissionais de Segurança Pública

**RECIFE-PE
2025**

CAPÍTULO 01

Histórico do APH-Tático no Mundo e no Brasil.

SUMÁRIO:

- Objetivos;
- Histórico;
- Medicina Tática;
- Normas/Legislações;
- APH-Tático na Segurança Pública.

OBJETIVOS:

Conhecer o histórico do APH-Tático no mundo e no Brasil;
Compreender o histórico do PH-Tático na Segurança Pública;
Reconhecer a importância do APH-Tático na Segurança Pública.

HISTÓRICO

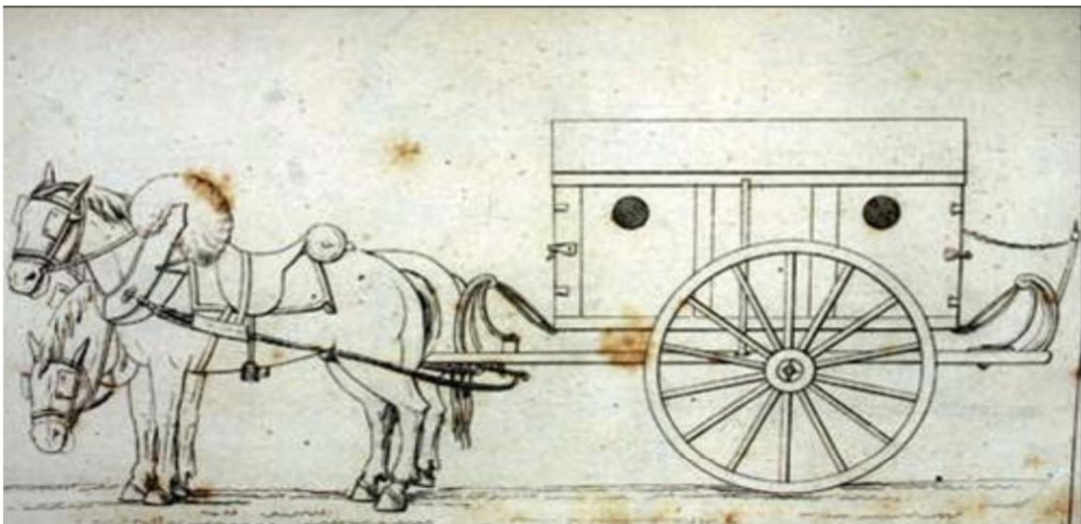
A história de atendimento pré-hospitalar pode ser dividida em quatro eras distintas.

Primeira era:

Era antiga, Egito, Grécia, Roma. Era realizado de forma rudimentar, simples, sem nenhum, ou quase nenhum, procedimento organizacional. Porém, já nessa época era vislumbrado a necessidade de tratar os feridos nas batalhas, buscando a volta para o combate.

Segunda era:

Era Larrey – Barão Dominique Jean Larrey, 1766 – 1842. Médico de Napoleão Bonaparte. Foi um precursor, criador das ambulâncias voadoras, visava a remoção rápida de feridos do campo de batalha.





Imagens das Ambulâncias Voadoras – Século XVIII

Treinamento para tratamento e transporte de feridos;
Triagem de feridos;
Hospitais de campanha;
Controle rápido de hemorragias externas.

Terceira era:

Era Farrington, 1950- 1970. Médico de cidade de Chicago – Estados Unidos da América/EUA, foi precursor nos EUA no tocante a padronização de materiais e equipamentos de APH nas ambulâncias;

Criou o 1º Curso de APH nos EUA, buscando a uniformização de procedimentos no atendimento pré-hospitalar, com procedimentos adequados, foco na desobstrução de vias aéreas e no controle de hemorragias.

Quarta era:

Implementação da medicina tática – Invasão do Kuwait / Guerra do Golfo 1990 – 1991.

Porém antes da Guerra do Golfo, houve um fato histórico importante que levou a um “start” da necessidade de mudanças nos protocolos de atendimento de militares feridos em combate. A **Guerra do Vietnã** 1955 – 1975.

Com dados alarmantes de aproximadamente 2500 (duas mil e quinhentas) mortes decorrentes de hemorragias em extremidades (membros inferiores e superiores), ou seja, de mortes evitáveis. Fato este que levou a uma grande repercussão e pressão interna nos EUA, sobre os jovens mortos no Vietnã. Que juntamente com outros fatores, levou a saída e derrota da guerra pelos EUA.

Após a Guerra do Vietnã verificou-se, que eram utilizados equipamentos inapropriados para a realidade tática, sem atentar para o ambiente hostil e dificuldades do terreno.



Abaixo, seguem alguns dados estatísticos de vítimas de Batalhas entre os anos de 1941 – 2005, vale ressaltar que são dados de militares dos EUA:

2ª GM	Vietnã	Oriente Médio
19.1%	15.8%	9.4%

Observa-se, uma redução praticamente 60% da taxa de mortalidade, entre 1975 (fim da Guerra do Vietnã) e 2005 (Guerras do Golfo, Iraque e Afeganistão).

Mas porque essa redução tão significativa?

Após a Guerra do Vietnã, os EUA vislumbraram a necessidade de mudanças para reduzir o número de baixas durante os conflitos. Assim, passaram por treinamentos massivos da tropa, aquisição e utilização de equipamentos mais adequados a realidade tática, menor tempo de evacuação, paramédicos mais preparados para a realidade tática com ênfase na contenção de hemorragias maciças, na desobstrução de vias aéreas, na manutenção da respiração, na implementação de hospitais de campanha mais próximos da linha de combate, minimizando assim, o tempo de resgate e evacuação dos feridos.

Ou seja, a redução deu-se devido a implementação do APH-Tático nas tropas Americanas, atualmente 100% dos militares americanos (Exército, Marinha, Forças Aérea, Força Nacional), são formados no TCCC.

Normas e Legislações

Considerando a idade dos conflitos armados no mundo, o Atendimento Pré-hospitalar Tático é uma temática recente, após 1975.

No Brasil, no tocante a Normas e Legislações que tratam do APH-Tático, temos a Portaria do Ministério da Defesa 16/2018 e a Portaria do Ministério da Justiça e Segurança pública 098/2022.

A primeira trata das questões do APH-Tático para as Forças Armadas.

PORTARIA NORMATIVA Nº 16/MD, DE 12 DE ABRIL DE 2018

Aprova a Diretriz de Atendimento Pré-Hospitalar Tático do Ministério da Defesa para regular a atuação das classes profissionais, a capacitação, os procedimentos envolvidos e as situações previstas para a atividade.

A segunda cria a Diretriz Nacional de Atendimento Pré-hospitalar Tático para profissionais de Segurança Pública.

PORTARIA Nº 98, DE 1º DE JULHO DE 2022

Cria a Diretriz Nacional de Atendimento Pré-Hospitalar Tático para Profissionais de Segurança Pública - APH-Tático.

No Brasil, o APH-Tático surgiu no ano de 1995 na cidade do Rio de Janeiro – RJ, com o Grupo de Paramédicos de Apoio Operacional – Resgate e Salvamento – GPAO/RS, um grupo dentro do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – BOPE/PMERJ.

Com o passar dos anos, crescimento e importância do APH-Tático para a Segurança Pública, criação e execução de cursos dedicados ao APH-Tático, bem como sua inclusão no Curso de Operações Especiais Policiais – Coesp, o GPAO-RS cresceu, deixou o BOPE e se tornou o Grupamento Especial de Salvamento e Ações de resgate – GESAR, tornando-se uma Organização Militar Estadual – OME independente no ano de 2006.

CAPÍTULO 02

Atendimento Sob Confronto Armado Fase 01 do APHT

SUMÁRIO:

- Objetivos;
- TCCC;
- Torniquete Tático - Autoaplicação;
- Atendimento Sob Confronto Armado;

OBJETIVOS:

Conhecer o TCCC e suas fases;
Aplicar corretamente o Torniquete Tático - TQ;
Reconhecer a importância do APH-Tático na Segurança Pública.

Fases do Atendimento Pré-hospitalar Tático ou APHT ou APH-Tático ou TCCC ou TC3, todas essas nomenclaturas, são sinônimos.

1ª Fase Atendimento Sob Confronto Armado ou Atendimento Sob Fogo;
Área Vermelha

2ª Fase Cuidados em Campo Tático ou Atendimento em Campo Tático;
Área Amarela

3ª Fase Atendimento em Evacuação Tática.
Área Verde

Neste Capítulo trataremos da 1ª Fase do APH-tático - Atendimento Sob Confronto Armado.

Deve-se buscar sempre abrigo, para evitar novas vítimas, revidar a injusta agressão assim que possível, se comunicar com os demais membros da equipe sempre. Para lembrar dessas ações existe o mnemônico F.A.C., que significa:

F - Fogo;
A - Abrigo; e
C - Comunicação.

No entanto, o que irá definir a ordem das ações, é situação/ocorrência, podendo o policial que primeiro vislumbrar a ameaça, se Comunicar com a equipe, indicando busca por abrigo.

Ou a depender da necessidade, realizar primeiro a resposta com arma de fogo, em seguida se comunicar e buscar abrigo;

Ou Buscar abrigo e se comunicar.

Batalha de Fallujah - Iraque

Considerada a maior batalha urbana após o fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu em 2004, na cidade de Fallujah no Iraque, onde temos relatos e imagens de uma patrulha toda sendo alvejada e neutralizada após 01 militar da patrulha ter sido atingido. Vejamos as fotos:



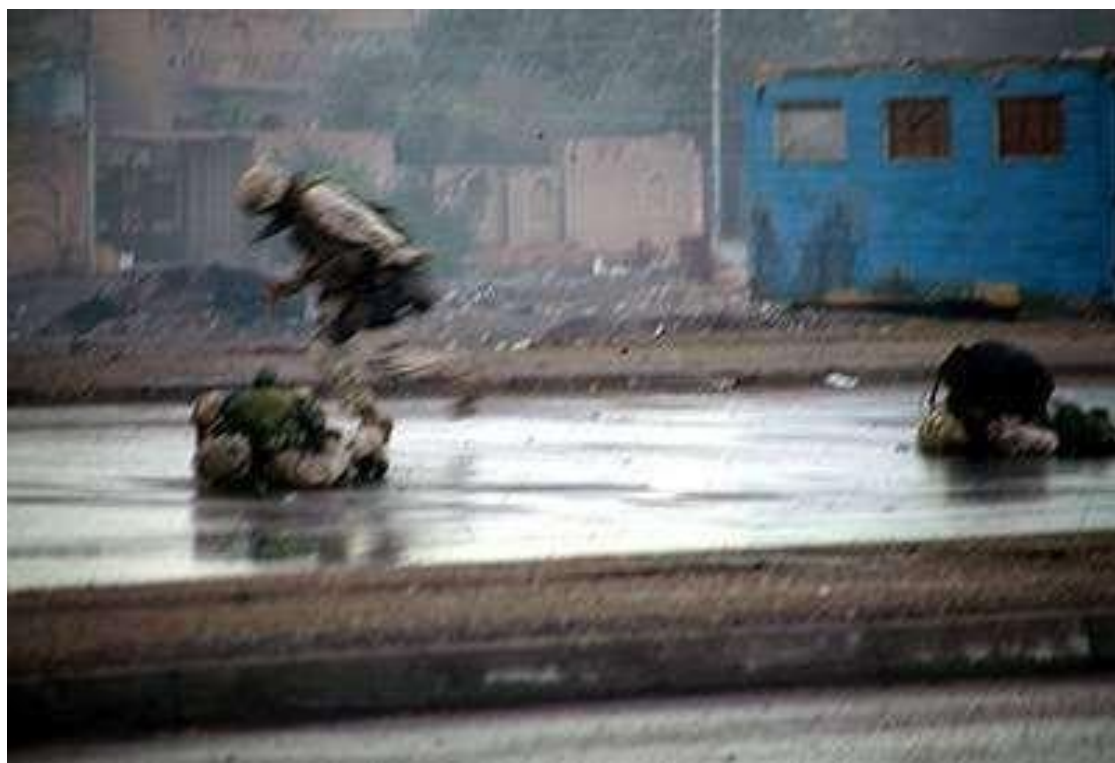
Durante troca de tiros o Sgt Ryan Shane, corre para puxar o Sgt Lonnie Wells para um abrigo próximo.



Outro militar, vem ajudar.



Mais um militar é alvejado.



Todos os militares da patrulha são alvejados.

IMPORTANTE

Se o confronto ainda estiver em andamento, **NÃO** tente de maneira nenhuma se aproximar (atender) da vítima. Pela alta probabilidade, de ser mais uma vítima.

Nesse caso, a supressão de fogo ao “inimigo”, a resposta a agressão e cobertura da vítima, já fazem parte do 1º Atendimento.

Após a neutralização ou fuga da ameaça, o que fazer?

O socorrista deve se comunicar e orientar a vítima...

Fulano... tás bem ??? fosse atingido onde??? consegue colocar teu Torniquete???

De acordo com as respostas da vítima o Socorrista irá se aproximar, identificar se existe sangramentos nas extremidades (membros superiores e inferiores) da vítima e aplicar o torniquete tático.

Em seguida irá arrastar a vítima até um abrigo.

LEMBREM-SE

Na 1ª Fase do APH-Tático, são realizados apenas esses procedimentos no tocante ao atendimento de ferido:

- Resposta a Agressão/Cobertura de Fogo;
- Comunicação/Orientação ao ferido;
- Autoaplicação de Torniquete Tático;
- Aplicação de Torniquete Tático;
- Técnicas de Arrasto para o abrigo.

Pergunta frequente de uma pessoa leiga

R - Mas tiro na perna mata????

Um rompimento de artéria causado por ferimento de arma branca ou por projétil de arma de fogo (PAF), pode levar a morte em menos de 5 (cinco) minutos.

Ex: artéria femural e artéria braquial.

O QUE FAZER?

OPERADOR CONSCIENTE E RESPONSIVO

O socorrista deve, orientar a vítima a realizar:

- Realizar o atendimento remoto;
- Orientar no tocante a identificação do ferimento; e
- Autoaplicação do torniquete tático, se indicado.

OPERADOR INCONSCIENTE E NÃO RESPONSIVO

O socorrista deve considerar que o ferimento é grave, e:

- Continuar abrigado, coberto e revidando a agressão (caso necessário);
- Preparar o plano de resgate para chegar até ao operador ferido/vítima;

Ao chegar na vítima, o socorrista deve:

- Retirar o armamento da vítima;
- Prioridade 1, controle de sangramentos maciços nas extremidades (hemorragias nos membros superiores e inferiores);
- Aplicação do torniquete tático, de maneira emergencial ou policial (alto a apertado, na parte mais proximal do membro), caso o socorrista não consiga identificar bem a origem do sangramento;
- Caso o socorrista consiga identificar a origem do sangramento, deve-se fazer uso da aplicação do torniquete tático, de maneira deliberada (de 05 a 07 cm acima do ferimento).

Pergunta frequente de uma pessoa leiga

Devo procurar e tratar todos os sangramentos na 1ª Fase do APH-Tático????

R - Não, apenas os sangramentos maciços nas extremidades, através da utilização/aplicação do Torniquete Tático.

Pergunta frequente de uma pessoa leiga

Aplico o Torniquete Tático por cima da farda mesmo???

R - Sim, na 1ª Fase do APH-Tático a autoaplicação ou a aplicação do Torniquete Tático, é realizada por cima do fardamento, atentando apenas para retirada de objetos que possam atrapalhar o aperto do Torniquete. Ex: coldre, objetos nos bolsos, braçal, etc.

Erros a serem evitados:

- Não usar o Torniquete Tático quando precisar;
- Usá-lo em sangramentos mínimos, não maciços;
- Retirá-lo quando a vítima estiver em choque;
- Afrouxá-lo periodicamente;
- Não apertá-lo o suficiente;
- Não utilizar um 2º Torniquete, quando necessário.

TORNIQUETE TÁTICO

É um dispositivo de oclusão externa temporário, que visa evitar a exsanguinação da vítima.

COMBAT APPLICATION TOURNIQUET (CAT GEN 7)



Tradução livre

Fonte: North American Rescue

CAPÍTULO 03

Cuidados em Campo Tático - M.A.R.C.H. Fase 02 do APHT

SUMÁRIO:

- Objetivos;
- Conceitos;
- Atendimento por grau de prioridades;
- Sistematização de procedimentos;
- Descrição das manobras.

OBJETIVOS:

Conhecer o mnemônico M.A.R.C.H.;
Realizar corretamente as manobras de contenção de hemorragias maciças, ênfase na Letra “M”;
Reconhecer a importância do APH-Tático na salvaguarda da vida.

Cuidados em Campo Tático ou Atendimento em Campo Tático 2ª Fase do APH-Tático Área Amarela

Após delimitar uma área segura, 1º abrigo, consiste no tratamento rápido dos ferimentos mais graves.

Mnemônico M.A.R.C.H.

M – Maciças hemorragias, contenção de hemorragias maciças;
A – Aéreas, desobstrução de vias aéreas;
R – Respiração, manutenção da respiração;
C – Circulação e Choque, “re-check” dos procedimentos, identificar sinais de choque;
H – Hipotermia, prevenção da hipotermia.

Maciça hemorragia – é a principal causa de mortes evitáveis;

Métodos de contenção de hemorragias:

- Pressão direta;
- Autoaplicação e Aplicação de Torniquete Tático;
- Preenchimento e empacotamento de Ferida;

Sangue venoso – maior concentração de dióxido de carbono CO₂, coloração mais escura;

Sangue arterial – rico em oxigênio O₂, coloração mais avermelhada (vermelho vibrante).

Pelas veias passam o sangue venoso, rico em CO₂;

Pelas artérias passam o sangue arterial, rico em O₂;

Vejamos abaixo a imagem do sistema circulatório:

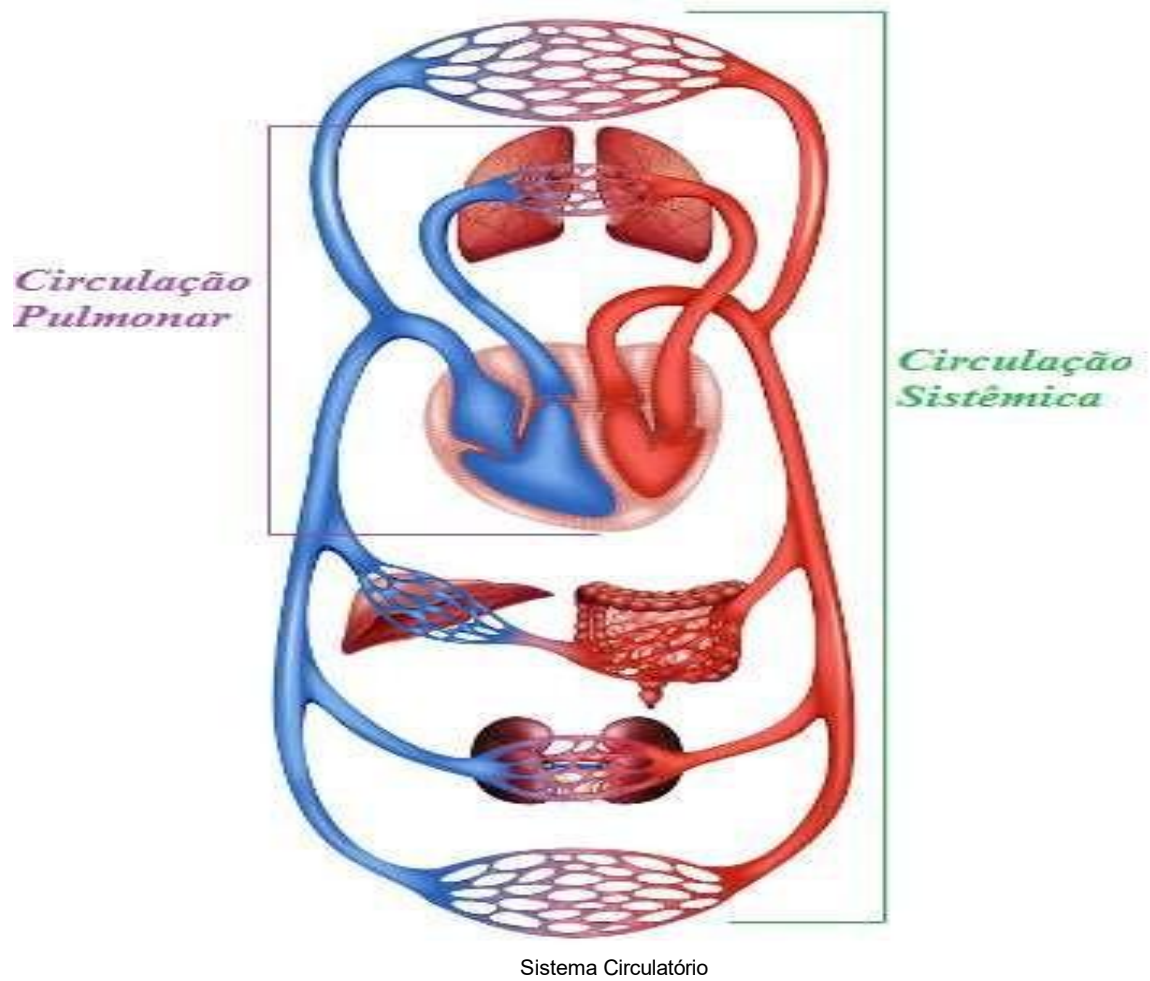
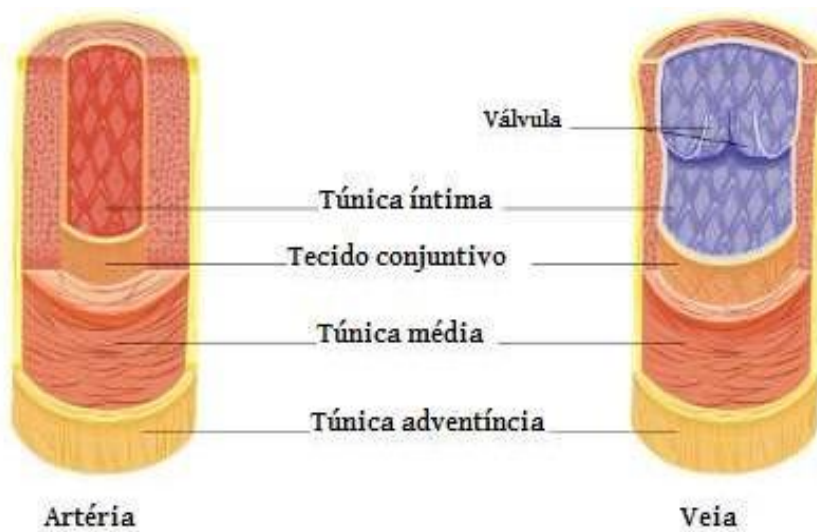


Imagem interna de artérias e veias:



M – Realizar varredura em busca de sangramentos que porventura não foram identificados ou tratados na 1ª Fase, ou que não estavam em extremidades e sim em regiões juncionais (hemorragias compressíveis).

Caso necessário, deve-se expor a vítima cortando-lhe as vestes, utilizando uma tesoura de ponta romba com a devida técnica:



Na utilização da técnica de pressão direta para contenção de hemorragias, existem materiais que aceleram o processo de coagulação sanguínea, chamados de agentes hemostáticos. Podem ser de origem mineral “**Caolim**” ou animal “**Quitozana**”.

Podendo ser encontrados como curativos, gazes e bandagens. Vejamos alguns exemplos:



Preenchimento de Ferida

Pode ser realizado com materiais **SEM** agentes hemostáticos, onde após o preenchimento a pressão deve ser realizada de 05 a 10 minutos sobre a ferida.

E quando realizado com materiais **COM** agentes hemostáticos, onde após o preenchimento a pressão deve ser realizada de 02 a 03 minutos sobre a ferida.

IMPORTANTE

Para preenchimento de feridas, deve-se sempre utilizar materiais contínuos.

Exemplo de gaze sem agente hemostático:



Gaze de metro, ou gaze de rolo tipo queijo.

O que fazer em caso de falha na contenção da hemorragia com esse método?

Com material **COM** agente hemostático, retira-se tudo e recomeça com um material novo.

Com material **SEM** agente hemostático, se mantém a pressão direta no local.

Empacotamento de Ferida

Após o preenchimento de ferida, é realizado o empacotamento da ferida, técnica que simula a pressão direta realizada pelo socorrista. Podem ser utilizados para tal:

- Ataduras crepom;
- Ataduras elásticas;
- Bandagem táctica (tipo israelense.)

Vejamos alguns exemplos:

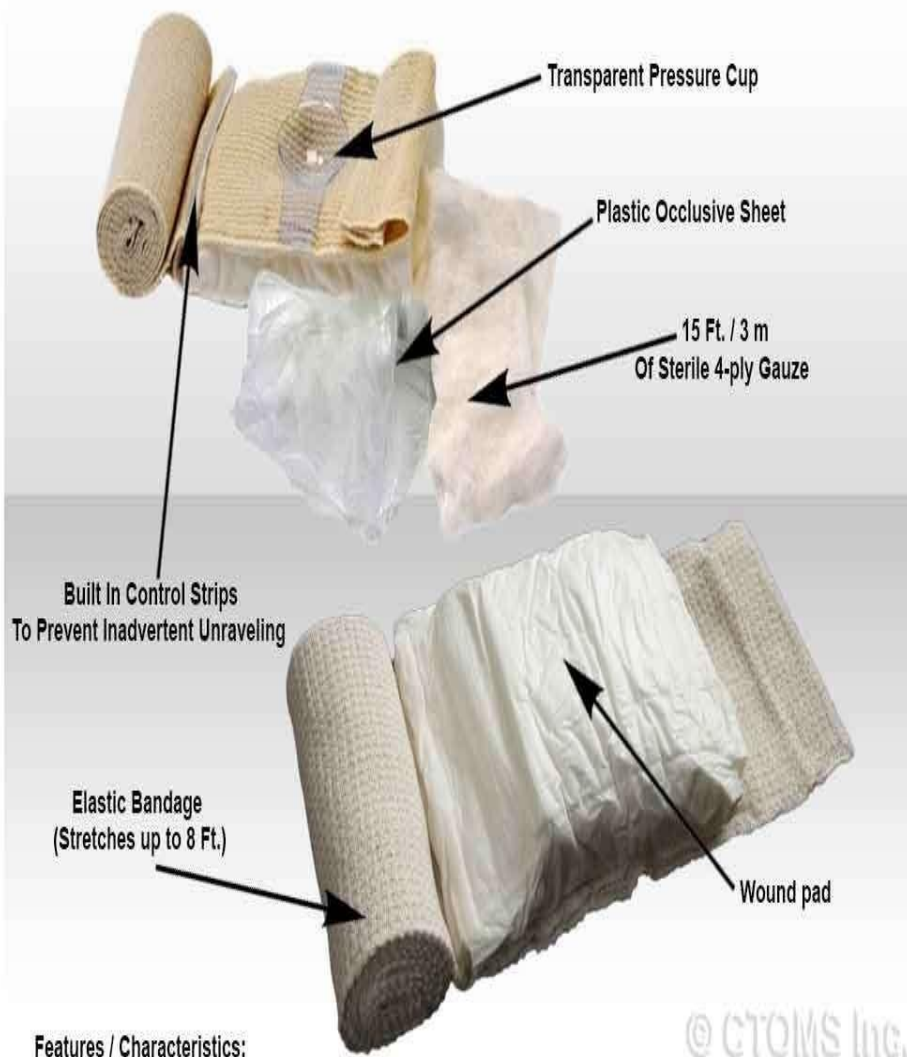


Atadura crepom



Bandagem elástica

OLAES® MODULAR BANDAGE



Features / Characteristics:



Bandagens táticas – Tipo israelense

CAPÍTULO 04

Cuidados em Campo Tático - M.A.R.C.H. Fase 02 do APHT

SUMÁRIO:

- Objetivos;
- Conceitos;
- Atendimento por grau de prioridades;
- Sistematização de procedimentos;
- Descrição das manobras.

OBJETIVOS:

Conhecer as manobras clínicas emergenciais de liberação de vias aéreas;
Conhecer técnicas de manutenção da respiração;
Realizar corretamente as manobras clínicas emergenciais de liberação de vias aéreas, como operador de APHT;
Utilizar técnicas e equipamentos para o tratamento de ferimento no tórax;
Reconhecer a importância do APH-Tático na salvaguarda da vida.

Cuidados em Campo Tático ou Atendimento em Campo Tático 2ª Fase do APH-Tático Área Amarela Ênfase na Letra A. e R.

A - Abertura de vias Aéreas

Dando sequência ao mnemônico M.A.R.C.H., seguimos após a contenção de hemorragias maciças, para desobstrução de vias aéreas e manutenção da respiração.

O socorrista deve posicionar-se lateralmente a vítima (operador ferido), e inspecionar se existe algum objeto ou secreção (sangue, vômito, fragmentos de dentes quebrados, chiclete, etc.), em seguida retirá-los com o dedo em forma de gancho (com luvas calçadas), impedindo assim que haja uma broncoaspiração. Mantendo em seguida na medida do possível, a cabeça da vítima lateralizada.

Vejamos a imagem a seguir:

1º passo: inspeção visual;

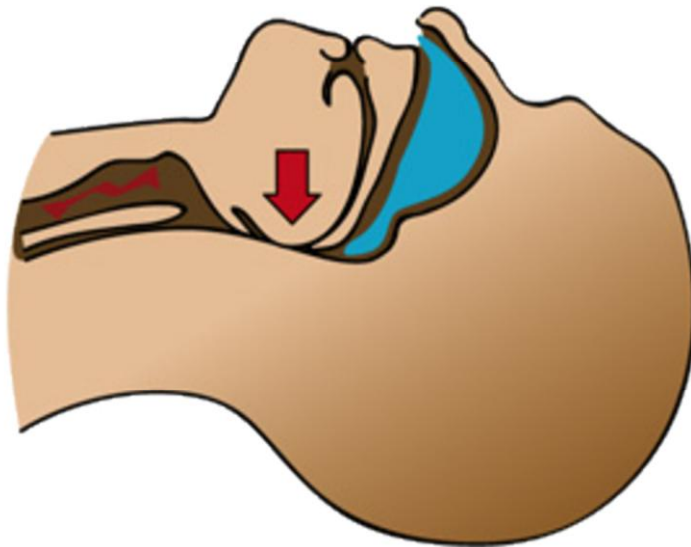
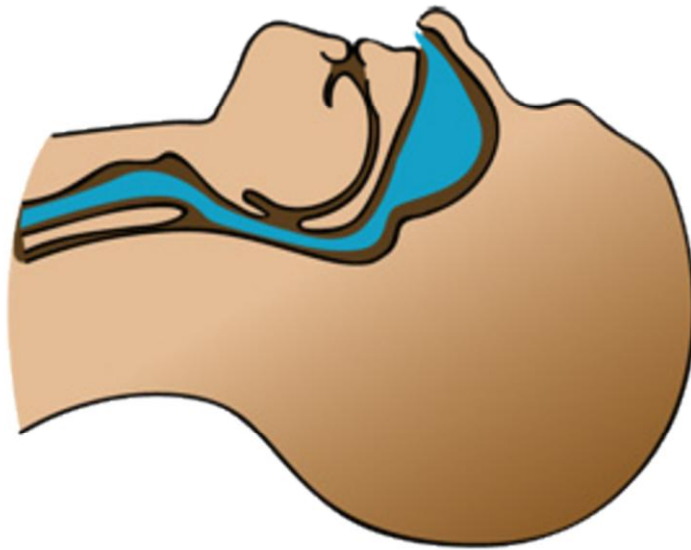
2º passo: desobstrução;

3º passo na medida do possível:
Lateralização.

IMPORTANTE:

A inconsciência gera perda do tônus muscular, o que pode causar relaxamento da língua sobre a hipofaringe, causando obstrução das vias aéreas.

Vejamos a imagem a seguir:



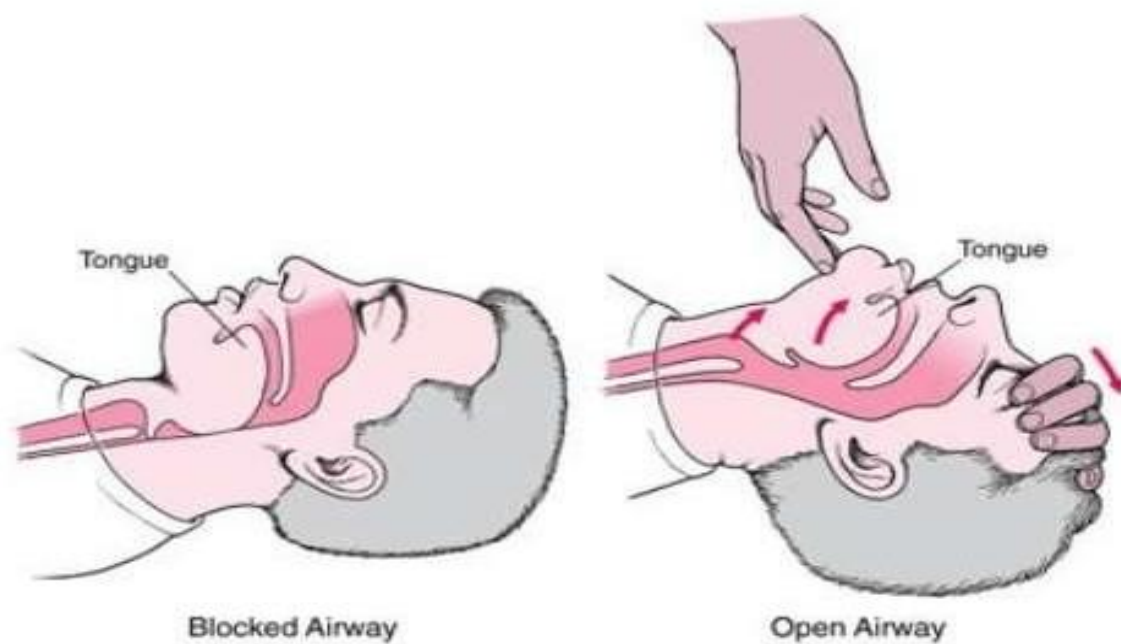
Abertura/Liberação de vias aéreas - Manobras

O socorrista deve posicionar-se atrás da vítima (operador ferido) para a realização de uma manobra de tração mandibular, conhecida como *Jaw Thurst*.

Vejamos a imagem a seguir:

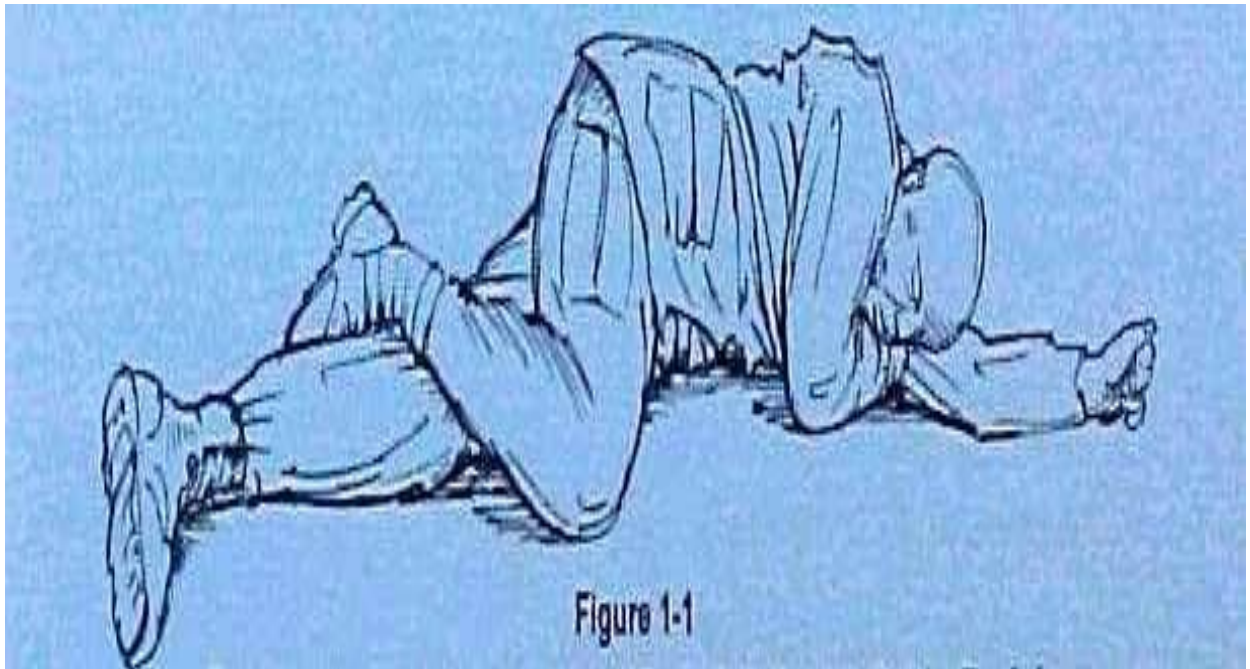
Outra manobra para realizar a abertura das vias aéreas, consiste na elevação do queixo da vítima, conhecida como *Chin Lift*.
Veamos imagem a seguir:

Cont. Head tilt / Chin lift



Em seguida, na medida do possível deixar a vítima lateralizada em posição de recuperação.

Vejamos imagem a seguir:



RESPIRAÇÃO LETRA - R

Dando sequência ao mnemônico M.A.R.C.H., seguimos após a contenção de hemorragias maciças, para desobstrução de vias aéreas e manutenção da respiração.

O Sistema Respiratório:

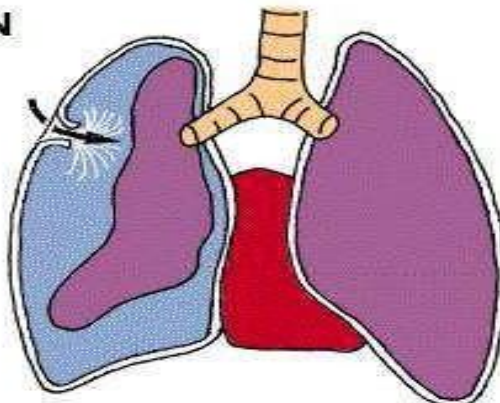
Brônquios – Iniciam na traqueia e vão se ramificando, originando os bronquíolos e alvéolos.

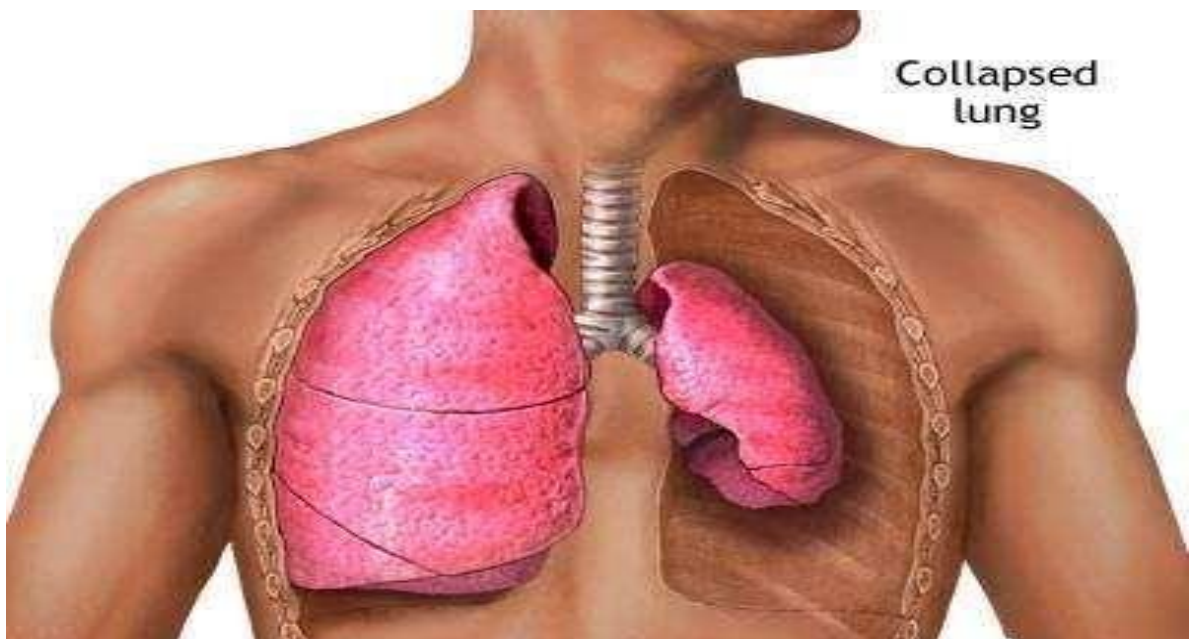
Pulmões – dividido em lóbulos que contém brônquios, bronquíolos e alvéolos.

Quando acontece uma perfuração no tórax pode ocorrer um “colapso” chamado de pneumotórax hipertensivo, vejamos:

Pneumotórax – é a presença de ar livre na cavidade pleural (membrana interna do tórax), causando uma diferença de pressão na cavidade pulmonar impedindo o pulmão de se expandir, causando muita dificuldade na respiração da vítima.

OPEN





No entanto, o pneumotórax hipertensivo é uma causa prevenível de morte no ambiente tático, seja ele decorrente de ferimentos penetrantes (perfuração por arma de fogo – PAF e/ou arma branca), ou decorrente de trauma fechado (explosão, PAF no colete balístico, ente outros).

Diagnóstico:

Dificuldade respiratória;
Turgência jugular;
Hipóxia.



O selo de tórax valvulado industrializado, é vendido em par, contendo:
01 unidade do selo de tórax valvulado (com a válvula); e
01 unidade do selo de tórax oclusivo (sem a válvula).

De forma que o selo com a válvula deverá ser colocado na lesão onde o socorrista identificar que está saindo o “ar”, que pode ser visto através da imagem de bolhas de ar junto com secreção e pelo som, com um pequeno chiado ou assobio leve.

Já o selo oclusivo, deverá ser colocado na lesão de saída (caso tenha).

Utilização



IMPORTANTE:

A válvula deve ser posicionada em cima da lesão.

Deve-se ainda periodicamente abrir o selo para limpeza da válvula e da lesão, com uma gaze comum estéril, impedindo assim a criação de coágulos e a espera da saída de mais ar, esta conhecida como manobra de *Burp*, em seguida deve fechar novamente o selo.

CAPÍTULO 05

Cuidados em Campo Tático - M.A.R.C.H. Fase 02 do APHT

SUMÁRIO:

- Objetivos;
- Conceitos;
- Atendimento por grau de prioridades;
- Sistematização de procedimentos;
- Descrição das manobras.

OBJETIVOS:

Identificar sinais de choque;
Realizar o “check” dos procedimentos já realizados;
Tratar hemorragias não maciças;
Utilizar técnicas e equipamentos para prevenção da hipotermia;
Reconhecer a importância só APHT na salvaguarda da vida.

Cuidados em Campo Tático ou Atendimento em Campo Tático 2ª Fase do APH-Tático Área Amarela Ênfase na Letra C. e H.

CIRCULAÇÃO E CHOQUE

Seguindo com o mnemônico M.A.R.C.H., chegamos a letra **C**, de circulação e choque. Nessa etapa, o socorrista irá realizar busca por ferimentos, hemorragias não maciças e tratá-las, em seguida irá checar todos os procedimentos já realizados nas “letras” anteriores do M.A.R.C.H., exemplos:

- Reajuste do Torniquete Tático;
- Verificação dos empacotamentos já realizados (se foram efetivos e sanaram a hemorragia);
- Verificação das vias aéreas;
- Manutenção da respiração (checagem e limpeza do selo de Tórax);

IMPORTANTE

O socorrista só para de verificar e “trabalhar” no paciente, quando o entregar no hospital, no ambiente intra-hospitalar.

O socorrista ainda na Letra **C**, deve identificar sinais de choque, exemplos:

- Checar pulso radial;
- Perfusão capilar lenta (tempo de preenchimento);
- Sudorese (podendo ser fria ou não);
- Confusão mental (nível de consciência);
- Palidez;

IMPORTANTE

O que fazer quando da vítima apresentar sinais de **CHOQUE**?

R- Dar celeridade do atendimento e levá-lo para o ambiente intra-hospitalar o mais breve possível.

PREVENÇÃO DA HIPOTERMIA

Na letra **H**, o socorrista deve efetuar procedimentos de prevenção da hipotermia, evitando assim a perda de calor corporal da vítima. Exemplos:

- Isolar a vítima do solo (sempre que possível);
- Retirar vestes molhadas (quando possível e indicado);
- Utilizar bolsas de calor instantâneo;
- Utilizar manta aluminizada;
- Quando em deslocamento em viatura convencional:
 - a) fechar os vidros do veículo;
 - b) ligar o ventilador do carro no modo “aquecedor”;
 - c) seguir com brevidade para o hospital, para entregar a vítima no ambiente intra-hospitalar.

IMPORTANTE

Hipotermia pode ser definida como a perda involuntária do calor corporal para abaixo de 35°C. Pode estar associada ao choque hemorrágico, que desestabiliza a capacidade termorreguladora do corpo (uma das funções do sangue é aquecer nosso corpo).

Vejam imagens de alguns materiais utilizados da prevenção da hipotermia:



Bolsas de calor instantâneo



Manta aluminizada

CAPÍTULO 06

Atendimento em Evacuação Tática - M.A.R.C.H. Fase 03 do APHT

SUMÁRIO:

- Objetivos;
- Conceitos;
- Atendimento em evacuação tática;
- Materiais utilizados;
- Tipos de evacuação;
- Prioridades na evacuação;

OBJETIVOS:

Conhecer técnicas e cuidados com o ferido durante a evacuação tática/
Aplicar técnicas específicas referentes à evacuação tática;
Minimizar os riscos durante o transporte de feridos;
Reconhecer a importância só APHT na salvaguarda da vida.

Atendimento em Evacuação Tática – consiste na 3ª Fase ou fase 3 do APHTático e compreende técnicas específicas para transferência adequada do ferido. Minimizando assim, os riscos durante o transporte enquanto os demais membros da equipe policial, mantém a capacidade de confronto caso necessário.

IMPORTANTE

Como fazer?

R- Utilizando técnicas específicas de transporte de feridos;

R- Utilizando técnicas de patrulha policial;

R- Em veículos não projetados, na maioria das vezes.

Ex: Veículos comuns e viaturas policiais convencionais.

Se prestarmos bem atenção, a evacuação tática começa desde a saída da área vermelha (fase 1) para área amarela (fase 2), da área amarela para a área verde (fase 3), até o hospital. **Respectivamente**, do confronto armado para o abrigo, do abrigo até o veículo de transporte, do veículo de transporte até a unidade hospitalar adequada.

Como material dedicado, temos a maca dobrável de transporte de ferido, também conhecida como maca táctica, ou maca de extração rápida, vejamos:



Técnicas de Transporte de Feridos

- Carregando pelos ombros;
- Técnica com 02 operadores;
- Técnicas com 03 operadores;
- Técnicas de mochilamento.

Técnicas de Embarque de Feridos em Veículos e Viaturas Convencionais

Técnicas de Embarque de Ferido em Plataformas Elevadas

Com a utilização da maca tática, a equipe (de acordo com a disponibilidade de efetivo) deverá se dividir lateralmente, pegando por exemplo:

02 socorristas de cada lado da maca;

Passo 01 – Chegando no local para embarque, o líder da equipe de socorristas que sempre fica a frente próximo da cabeça da vítima, irá comandar para que a vítima seja posicionada na altura correta do embarque, seja ele na altura da linha da cintura ou na altura da linha dos ombros.

Passo 2 – Em seguida, também sob comandamento do líder da equipe, irão aos poucos inserir, colocar a vítima na plataforma elevada.

IMPORTANTE

Caso não tenha um socorrista dentro do veículo (plataforma elevada), um dos socorristas da equipe, deverá embarcar (subir) na plataforma elevada, para puxar e ajudar no embarque da vítima.

Para muitos o Atendimento em Evacuação Tática, é a fase mais complexa do APH-Tático. Pois após a estabilização do ferido nos Cuidados em Campo Tático (Fase 2), corre-se:

- Risco de agravamento das lesões da vítima;
- Risco de novos confrontos com marginais após a saída do abrigo;
- Dificuldades de locomoção com a vítima, devido ao trajeto, ao terreno, aos meios e ao número de policiais da equipe;

Antes de sair do abrigo, o líder da equipe de socorrista deve:

- Planejar a evacuação tática;
- Definir o meio de transporte mais adequado;
- Definir qual a melhor técnica para o transporte de ferido naquela ocasião de acordo com o terreno, meios e pessoal disponível;

IMPORTANTE

Seja proativo, não espere um mal acontecer para realizar um planejamento, um *briefing* com sua equipe, como mais antigo da equipe de serviço, procure sempre no início de cada serviço:

- Verificar rotas de emergência, para um possível socorro de urgência;
- Quem irá dirigir a viatura, caso o motorista tenha um mal súbito ou venha a ser ferido?
- Onde as chaves da viatura ficam?
- Para qual unidade de saúde deslocar?
- É necessário que seja um centro cirúrgico, unidade de trauma de grande porte;
- Se a vítima já está estabilizada, não adianta levar para Unidades Básicas (ex: Unidades de Pronto Atendimento – UPA);
- Quando em deslocamento em viatura convencional (prevenção da hipotermia):
 - a) fechar os vidros do veículo;

- b) ligar o ventilador do carro no modo “aquecedor”;
- c) seguir com brevidade para o hospital, para entregar a vítima no ambiente intra-hospitalar;
- Seguir durante todo o deslocamento monitorando, recheando, trabalhando na vítima;
 - a) Letras C e H do M.A.R.C.H.;
 - b) Reavaliar periodicamente os procedimentos que já foram feitos, letras M.A.R.;
- O socorrista só para de monitorar e trabalhar na vítima, quando a entregar no ambiente intra-hospitalar.

REFERÊNCIAS:

- BRASIL. Portaria MJSP Nº 98, de 1º de julho de 2022. Cria a Diretriz Nacional de Atendimento Pré-hospitalar Tático para Profissionais de Segurança Pública. Brasília: ministério da Justiça e Segurança Pública, 2022;
- BRASIL. Portaria Normativa nº 16/MD, de 12 de abril de 2018. Aprova a Diretriz de Atendimento Pré-hospitalar Tático do Ministério da Defesa. Brasília: Ministério da Defesa, 2018;
- BUTLER, FK. Two Decades of Saving Lives on the battlefield: Tactical Combat Casual Care Turns 20. Military Medicine. 2017. Mar 1;182(3):e1563-8;
- FBSP. Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2022. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ano 16-2022. ISSN 1983-7364. São Paulo: FBSP, 2022;
- FBSP. Revista Brasileira de Segurança Pública. V. 17, N. 1. Fev/mar 2023. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. ISSN 1981-1659 versão impressa, ISSN 2595-0258 versão eletrônica. São Paulo: FBSP, 2023;
- NAENT. PHTL: Prehospital Trauma Life Support, Military Edition. 9th ed. National Association of Emergency Medical Technicians. EUA: Jones e Bartlett Publishers, 2019;
- UNODC. Global Study on Homicide-2019. Viena, 2019.